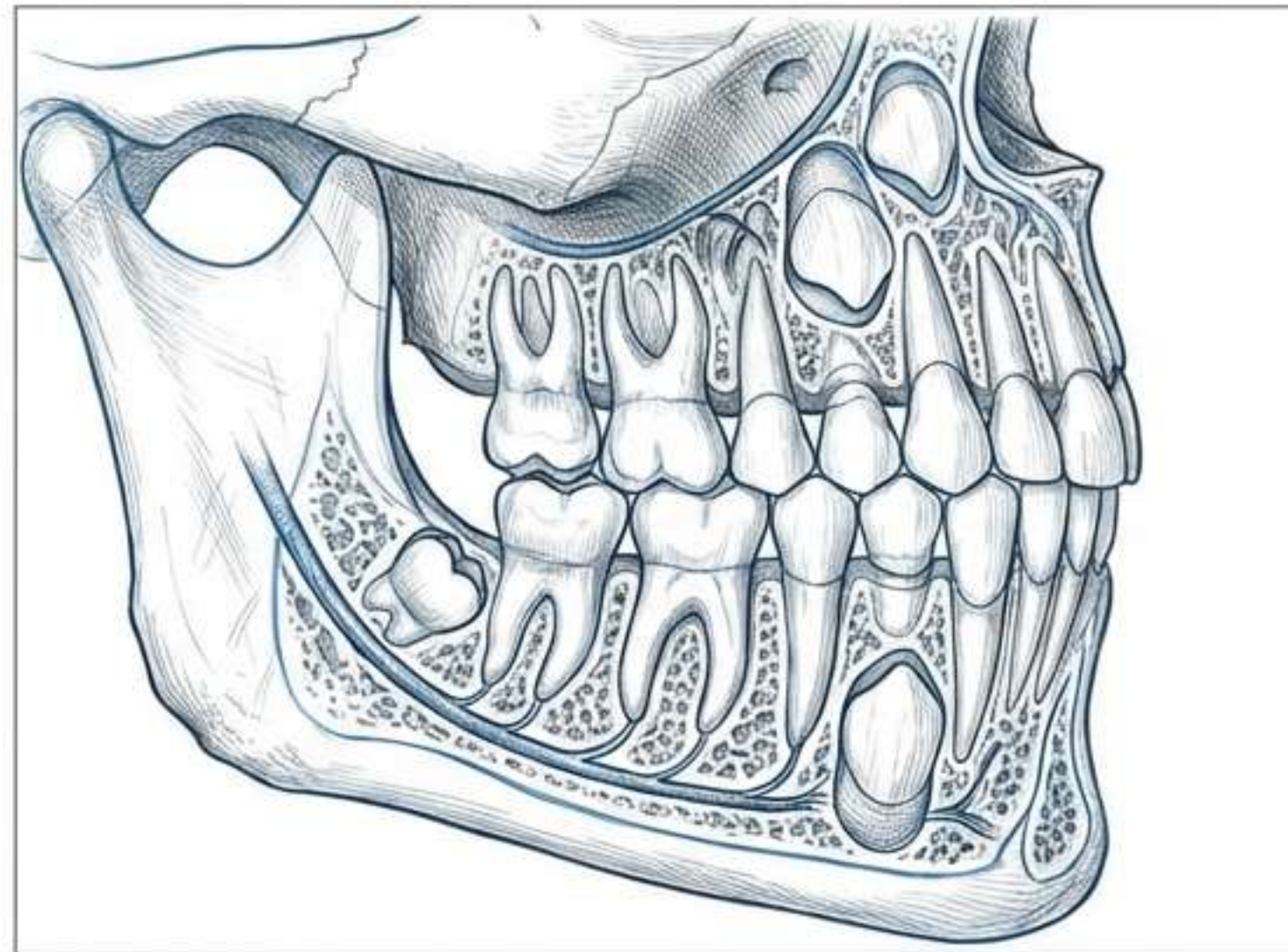


# Éruptions dentaires normales et pathologiques

Faculté de Médecine d'Alger

Département de Médecine Dentaire | Service de Pathologie et Chirurgie Buccale

Cours de 2<sup>ème</sup> Année / Dr. BOUFATIT





# Définition & Mécanismes Essentiels

**Définition Supérieure :** L'éruption dentaire est un phénomène physiologique qui permet à une dent de faire irruption dans la cavité buccale jusqu'à une position fonctionnelle [Ref: Q17(2021), Q4(2024)].

## Mécanismes Essentiels :

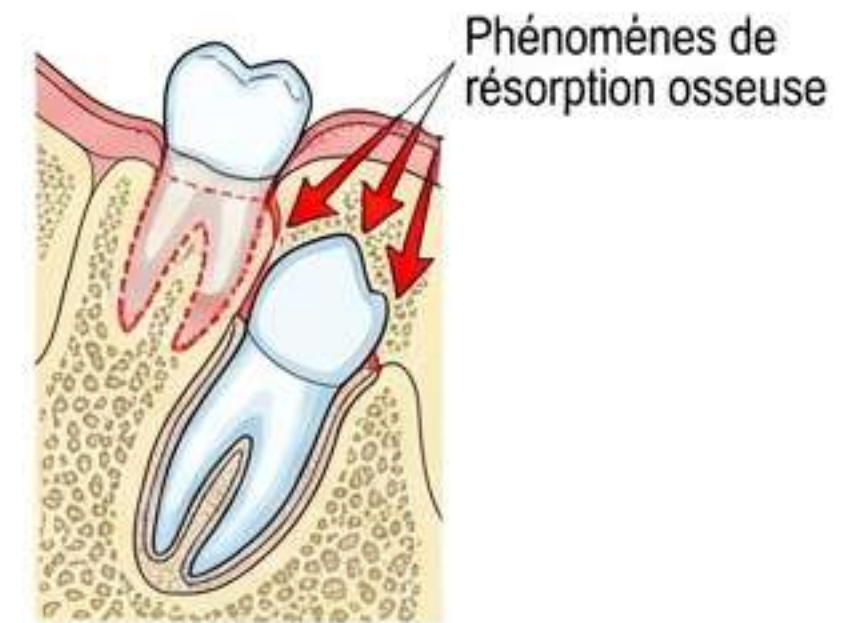
- Elle fait intervenir notamment des phénomènes de résorption osseuse [Ref: Q11(2020)].
- L'éruption des dents permanentes est précédée par la résorption des dents temporaires jusqu'aux prémolaires [Predicted - Key mechanical transition limit].

## Classification des Anomalies (Il faut distinguer) :

1. Les accidents d'éruption (généralement inflammatoires)
2. Les anomalies chronologiques (retard et avance)
3. Les anomalies topographiques.



STAGE 1



STAGE 2



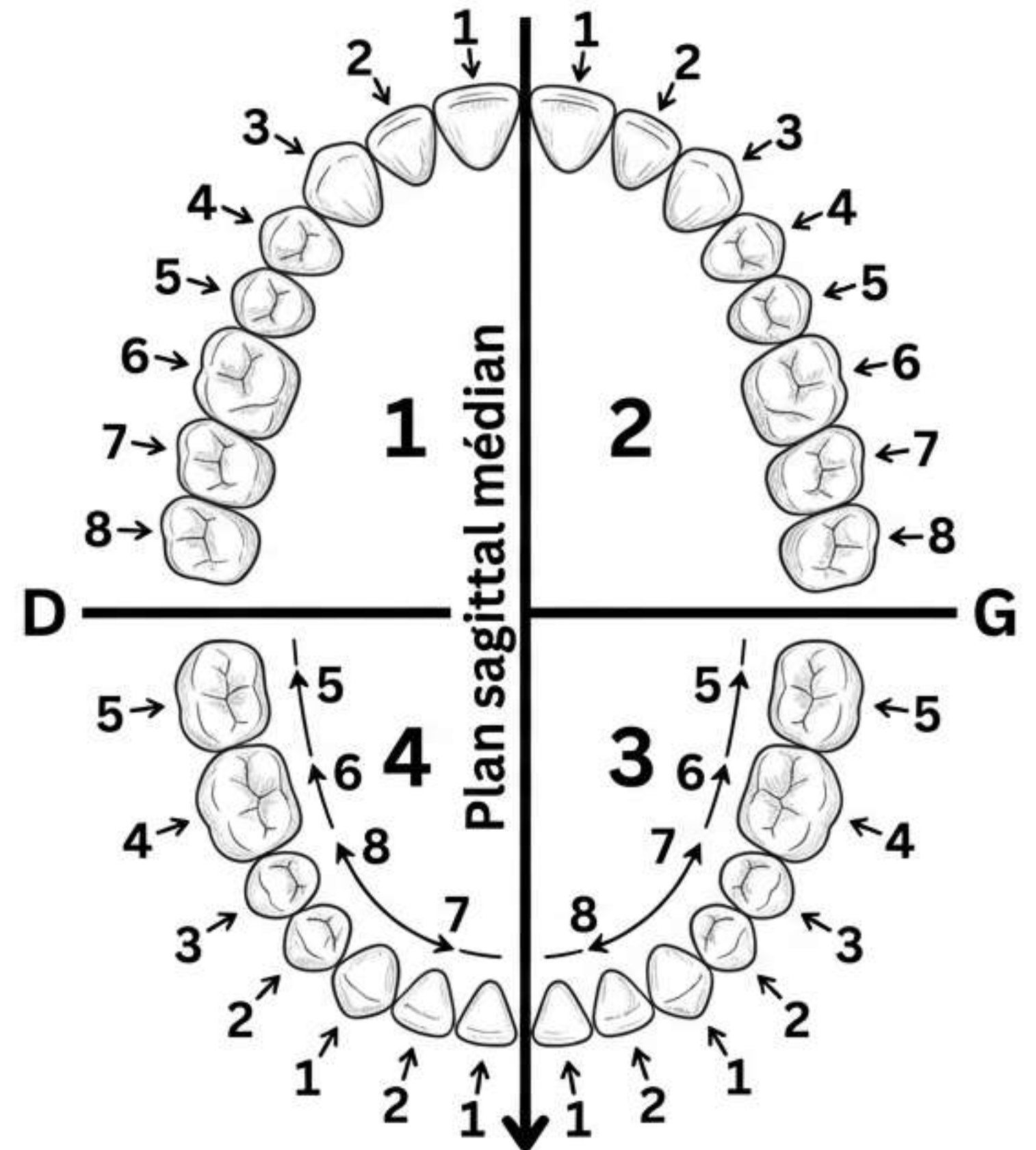
STAGE 3



# Systeme de Numérotation Internationale (FDI)

**Numérotation Internationale :** Les dents sont disposées sur deux arcades dentaires, dont chacune peut être divisée en deux moitiés (hémi-arcades) symétriques par rapport à un plan sagittal médian.

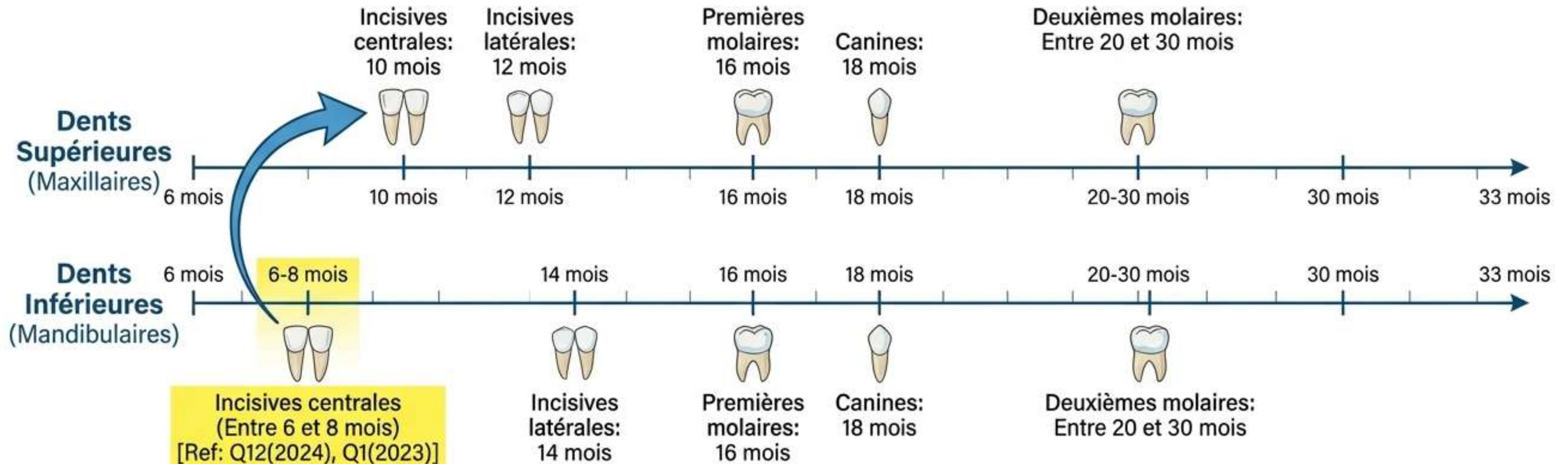
- **Composition des Quadrants :**
  - Pour la denture temporaire : 5 dents par quadrant.
  - Pour la denture définitive : 8 dents par quadrant.





# Chronologie de l'Éruption Normale : Denture Temporaire

**L'éruption dentaire normale (Denture Temporaire) :** Processus par lequel une dent traverse la gencive et devient visible dans la bouche. Concerne les 20 dents temporaires ou 'dents de lait'. Débute vers 6 mois et se termine autour de la troisième année.

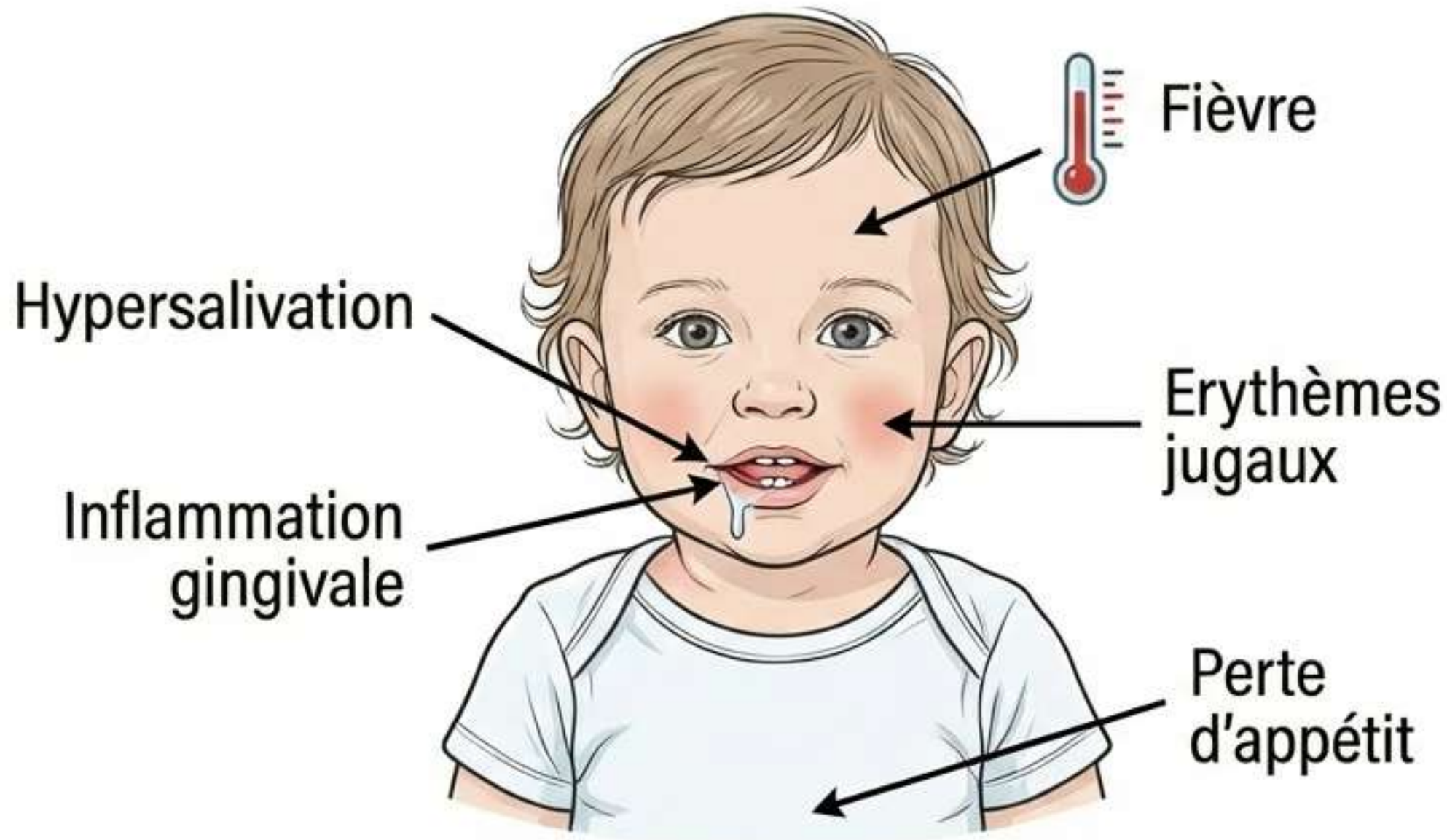




# Signes Cliniques de l'Éruption Temporaire

**L'éruption des dents temporaires** s'accompagne fréquemment de signes locaux ou généraux bien connus.

## Signes Bénins



## Signes à Caractère Plus Grave (Exceptionnels)

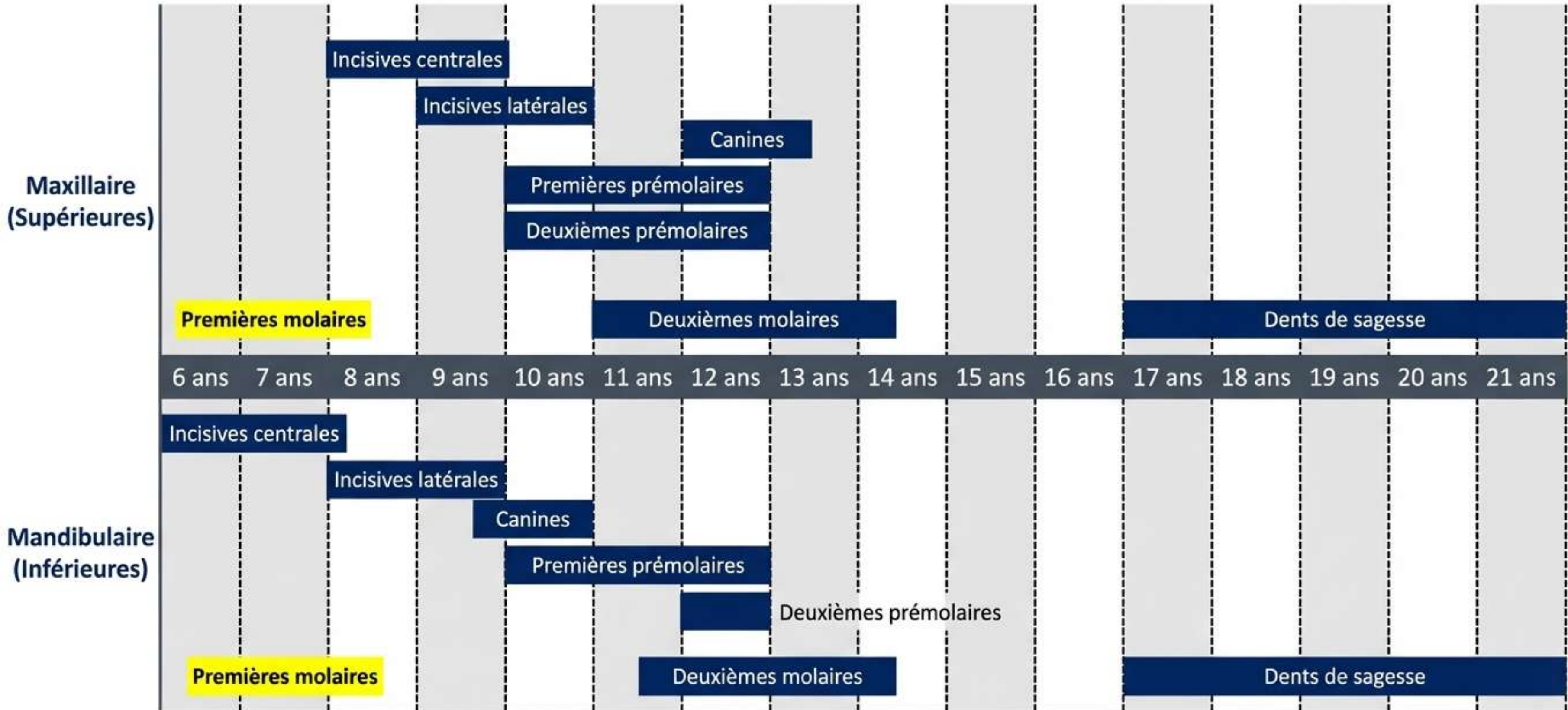
Fièvre élevée

Crises convulsives

Troubles respiratoires ou digestifs [Predicted - Specific systemic complication]



# Chronologie Normale : Les 32 Dents Définitives

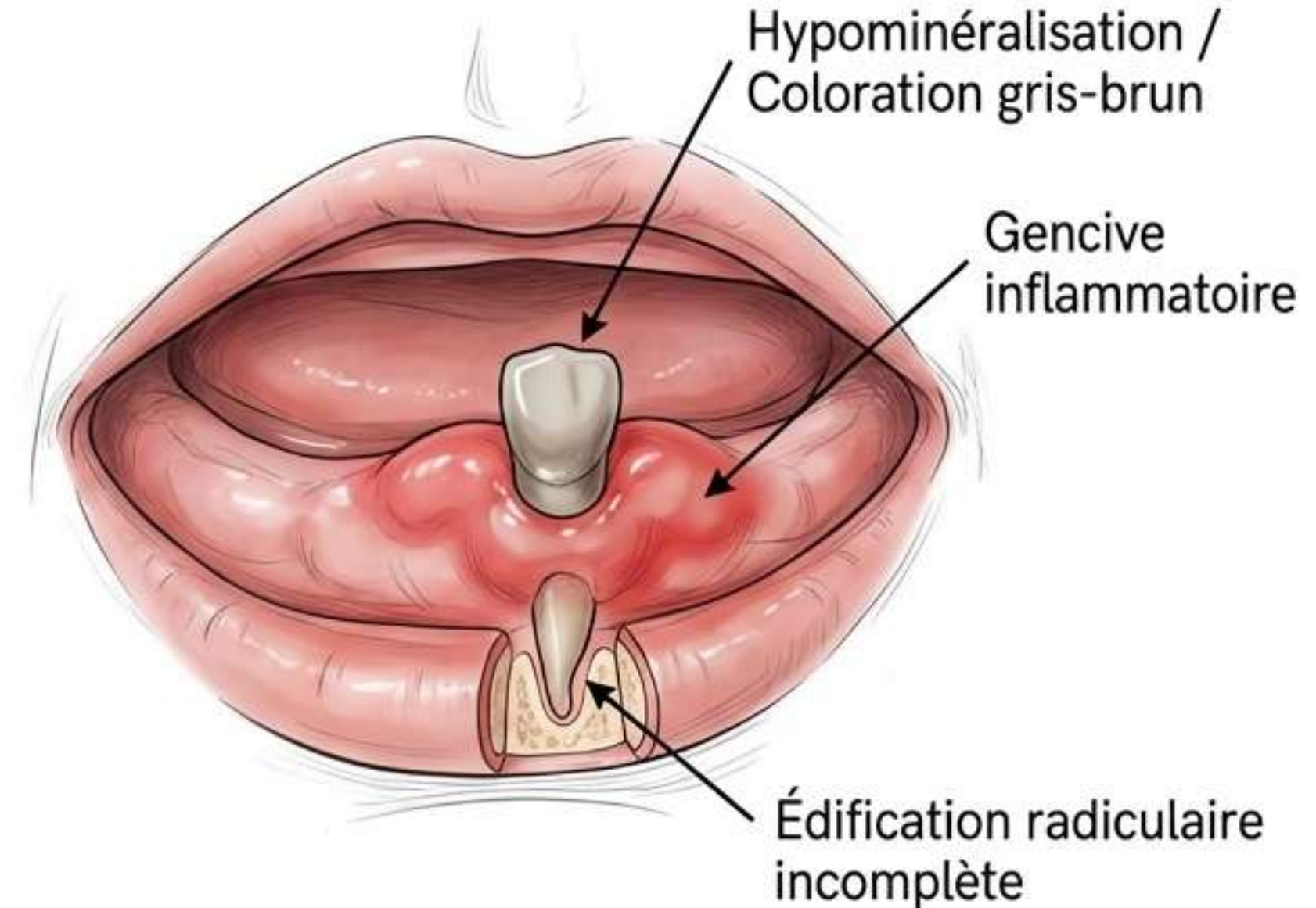




# Anomalies Chronologiques : Dents Natales et Néo-Natales

## III.1. La poussée dentaire précoce et prématurée

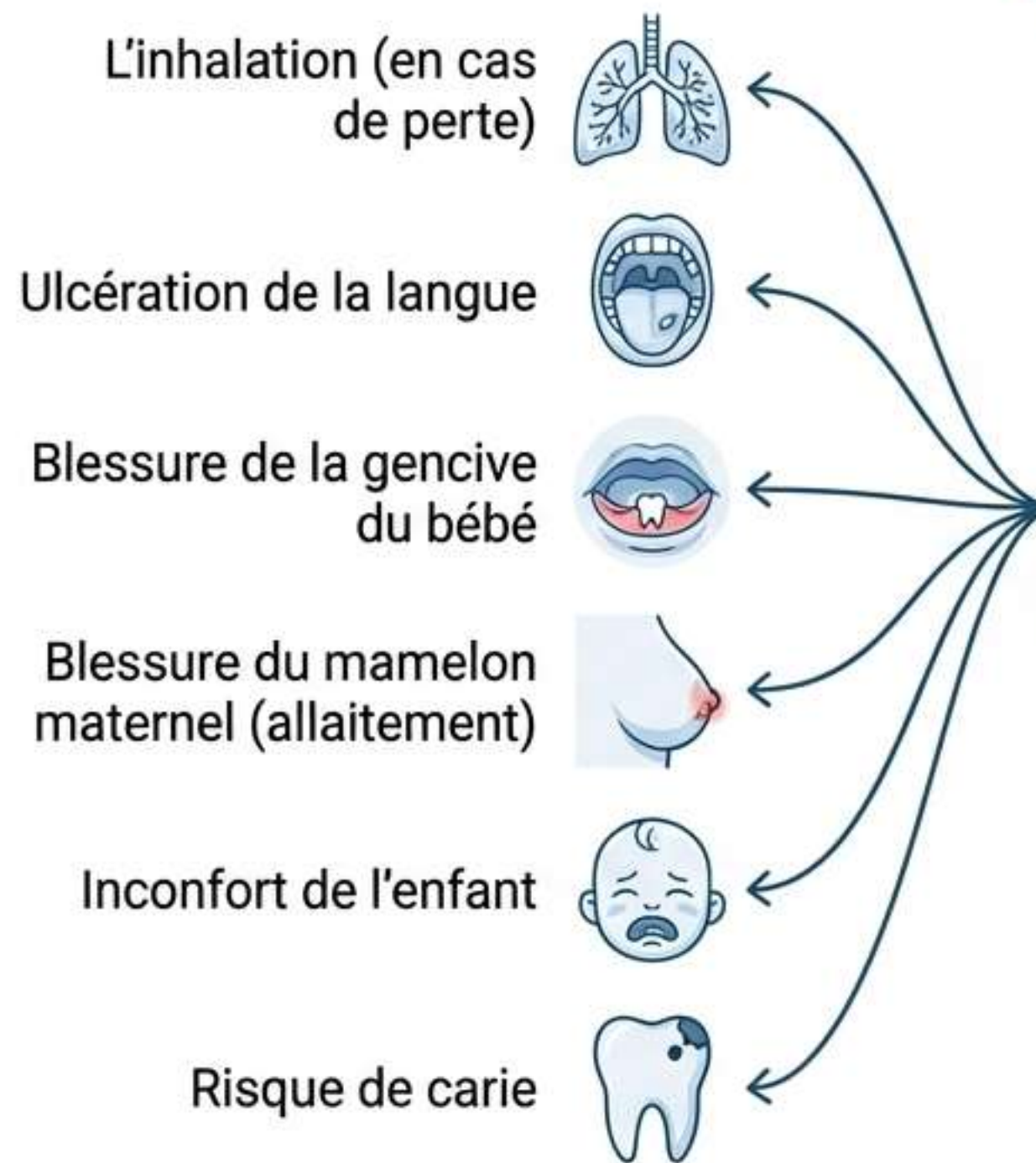
- **1. Dents natales et néo-natales** : Rare, une naissance sur 6 000.
- **"Dents natales"** : Concernent généralement les incisives centrales (présentes à la naissance).
- **Néo-natales** : Elles font leur apparition durant le premier mois de vie [Ref: Q1(2021), Q9(2019)].
- **Présentation Clinique** : Coloration gris-brun associée à une hypominéralisation de l'émail surtout au niveau cervical [Ref: Q1(2022)].
- Entourée d'une gencive inflammatoire. Une édification radiculaire incomplète conduit à la mobilité puis la chute précoce de la dent [Ref: Q1(2022)].
- **Action clinique** : Conséquences négatives possibles, extraction souvent choisie.





# Risques et Étiologies des Dents Natales

## Risques Locaux et Mécaniques



## Étiologies & Syndromes Associés

Étiologie Inconnue

Position superficielle du germe, origine infectieuse, origine tumorale, manœuvres obstétricales.

Syndromes Malformatifs (>50)

Trisomie 13, fentes palatines, dysostoses craniofaciales [Predicted - Highly testable multi-system linkages]





# Diagnostic Différentiel : Éruption Précoce vs Précoce

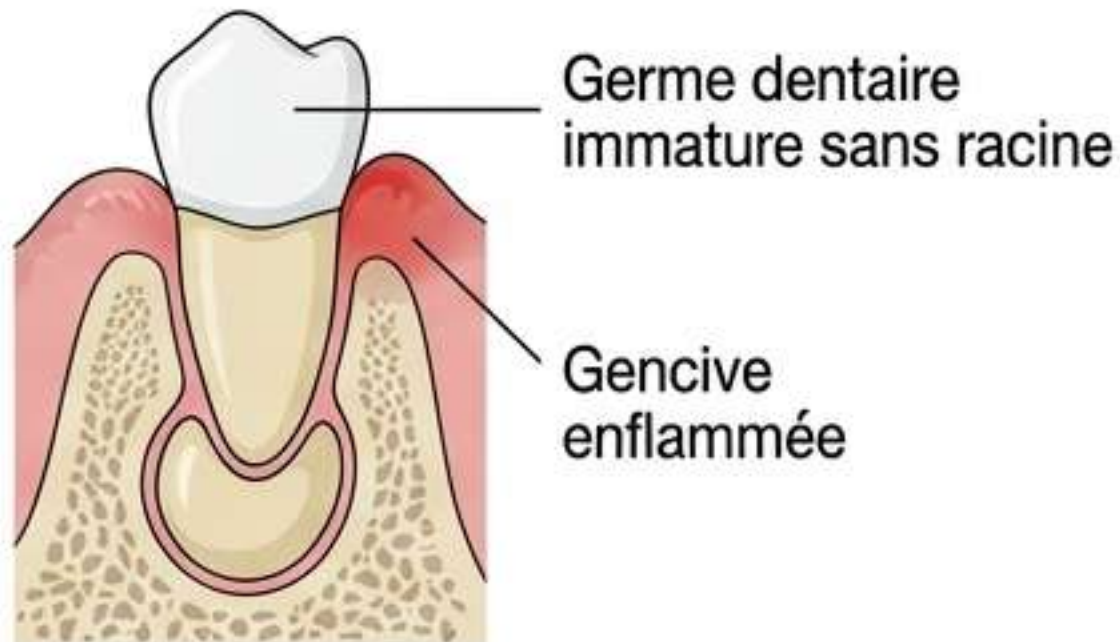
**A**

## 2. Éruption Précoce

- Elle amène sur l'arcade une dent immature, encore à l'état de germe.

3 causes distinctes :

- Traumatique
- histiocytose x [Predicted - Specific pathology].
- Infectieuse : folliculite.



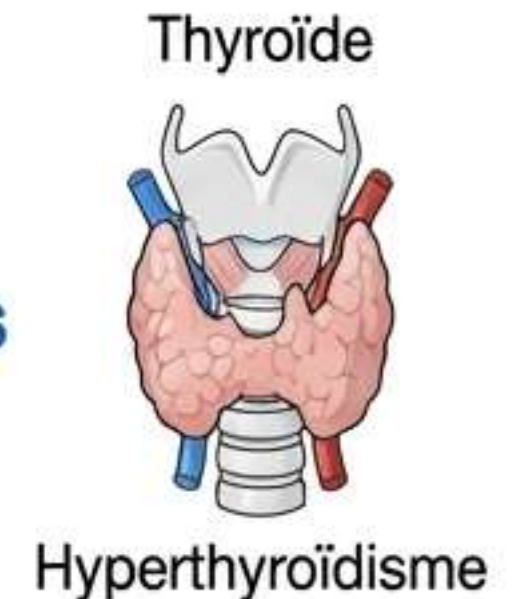
**B**

## 3. Éruption Précoce

- Rare, survient de 1 mois à 6 mois avant la date normale d'éruption.

Principales causes :

- Position superficielle du germe
- Hyperthyroïdisme [Ref: Q17(2019)]
- Puberté précoce
- Fente palatine
- Trisomie 13....





# Anomalies Chronologiques en Denture Permanente

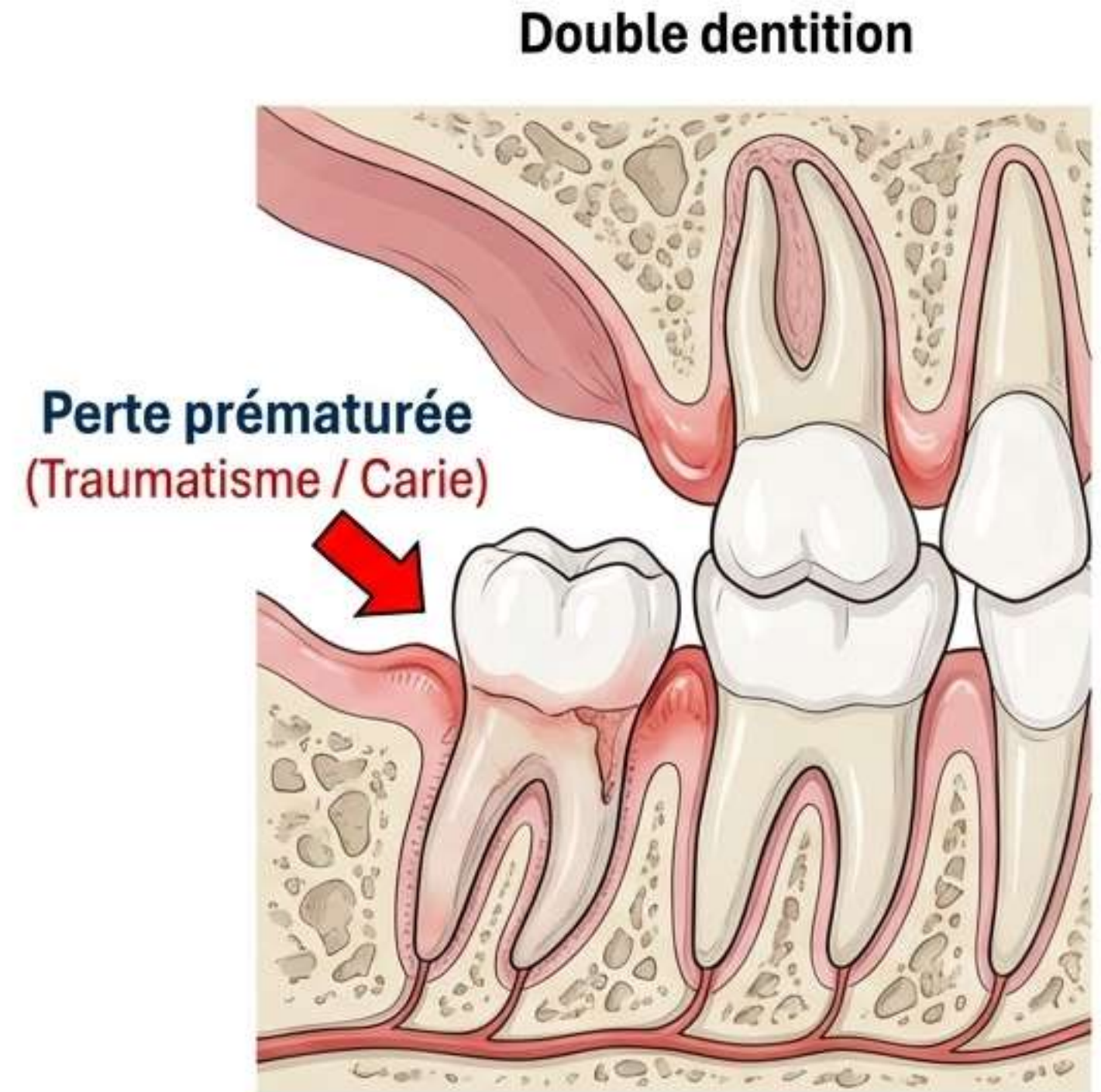
## Poussée précoce et prématurée (Denture Permanente)

### Situation de Double Dentition (Temporaire) ++ :

- Des dents définitives poussent alors que les dents de lait ne sont pas encore tombées.
- Consécutive à la **perte prématurée d'une dent temporaire**, en raison d'un traumatisme, carie, ou d'une pathologie infectieuse [Ref: Q5(2024), Q8(2024), Q8(2023)].

### Éruption précoce de TOUTE la dentition définitive :

- En revanche très rare. Souvent liée à une puberté précoce ou à un hyperthyroïdisme.

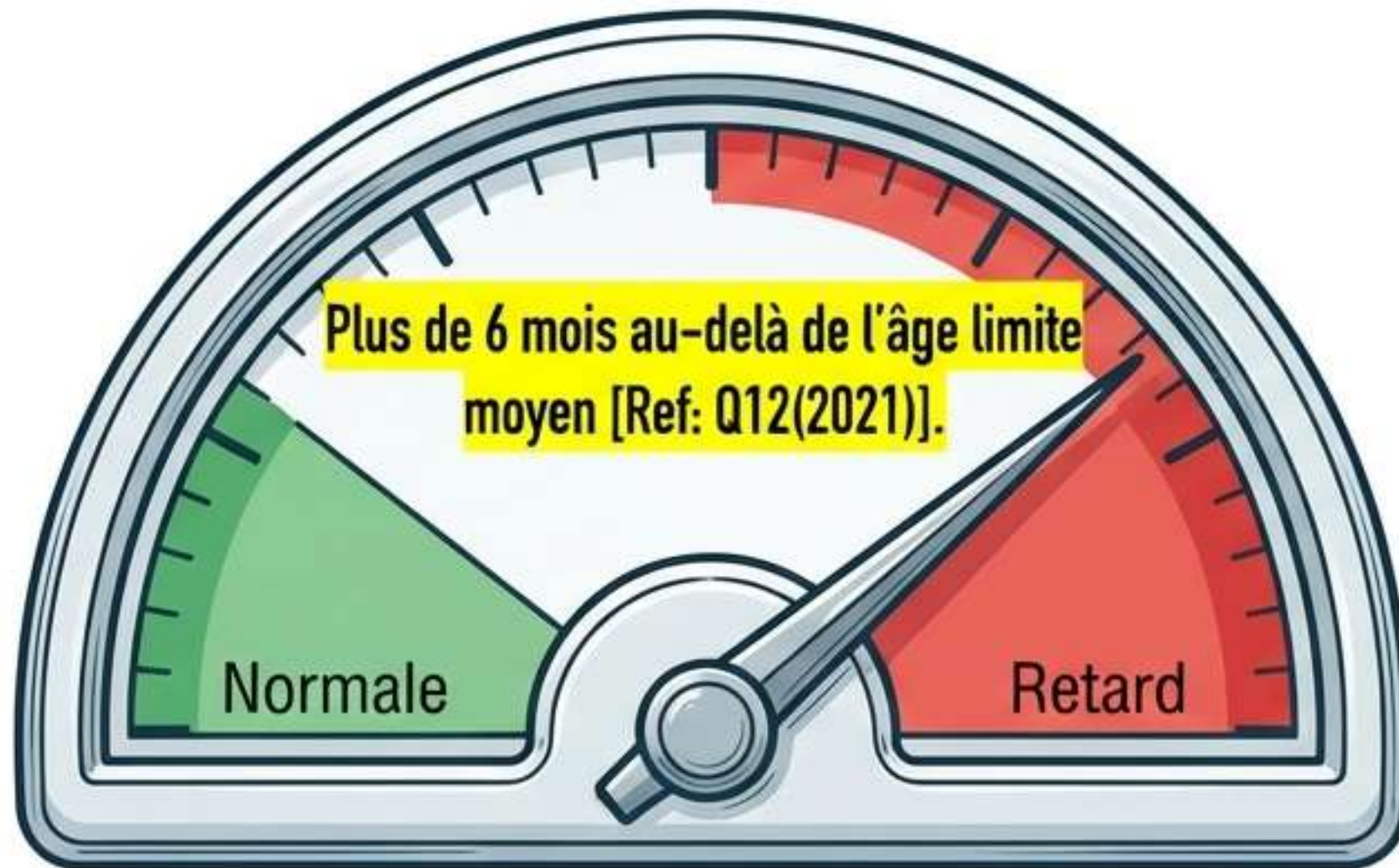




# Définition Médico-légale : L'Éruption Retardée

## III.2. Éruption dentaire retardée : Définition

On considère que l'éruption est retardée lorsqu'elle a lieu :



### En Denture Temporaire

C'est plus rare qu'en denture permanente.  
Étiologie locale ou générale.



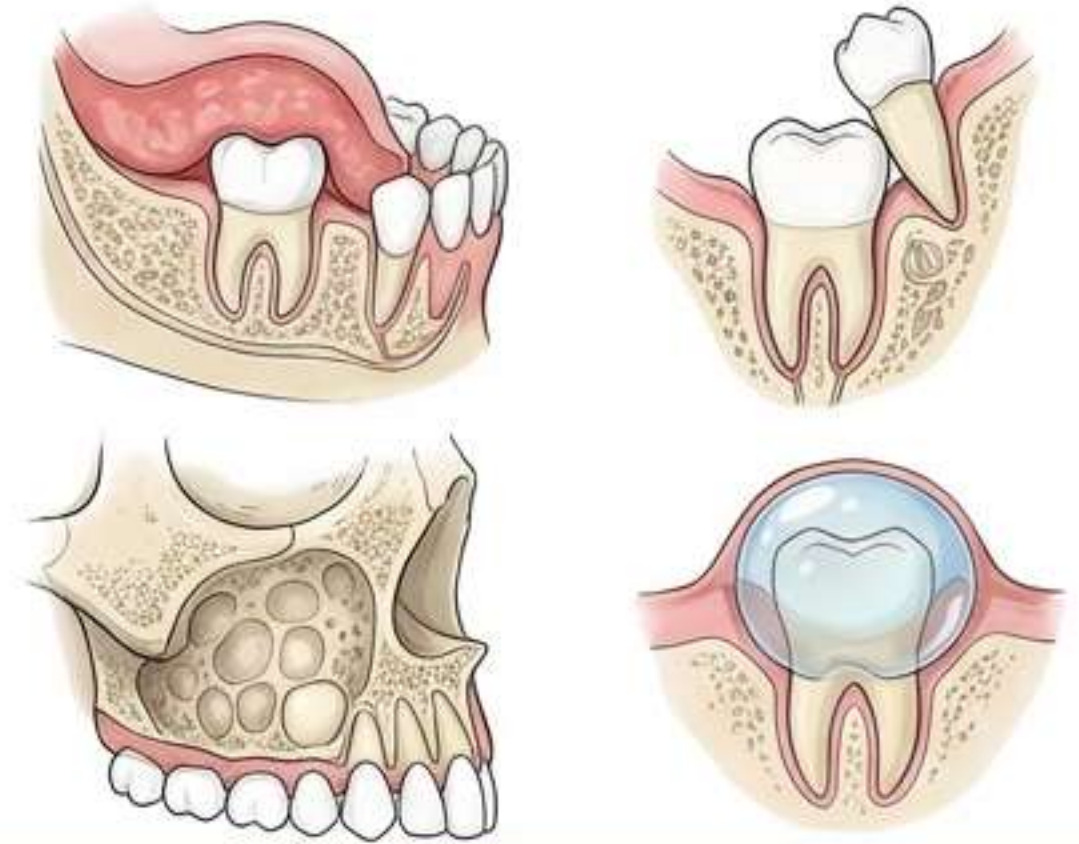
### En Denture Permanente



# Étiologies du Retard en Denture Temporaire

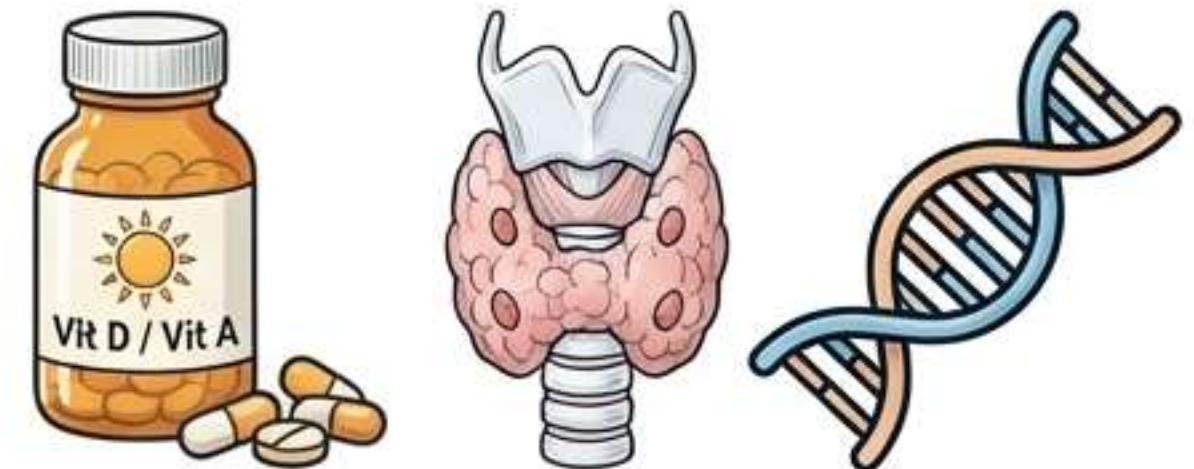
## Étiologies Locales (Obstacles)

- **Gingivaux** : hyperplasie congénitale, médicamenteuse.
- **Dentaire** : dents surnuméraires...
- **Osseux** : **chérubisme** (expansion progressive des maxillaires) [Predicted - Bone pathology definition].
- **Tumoraux** : kyste d'éruption, odontomes, épulis...



## Étiologies Générales (Systémiques)

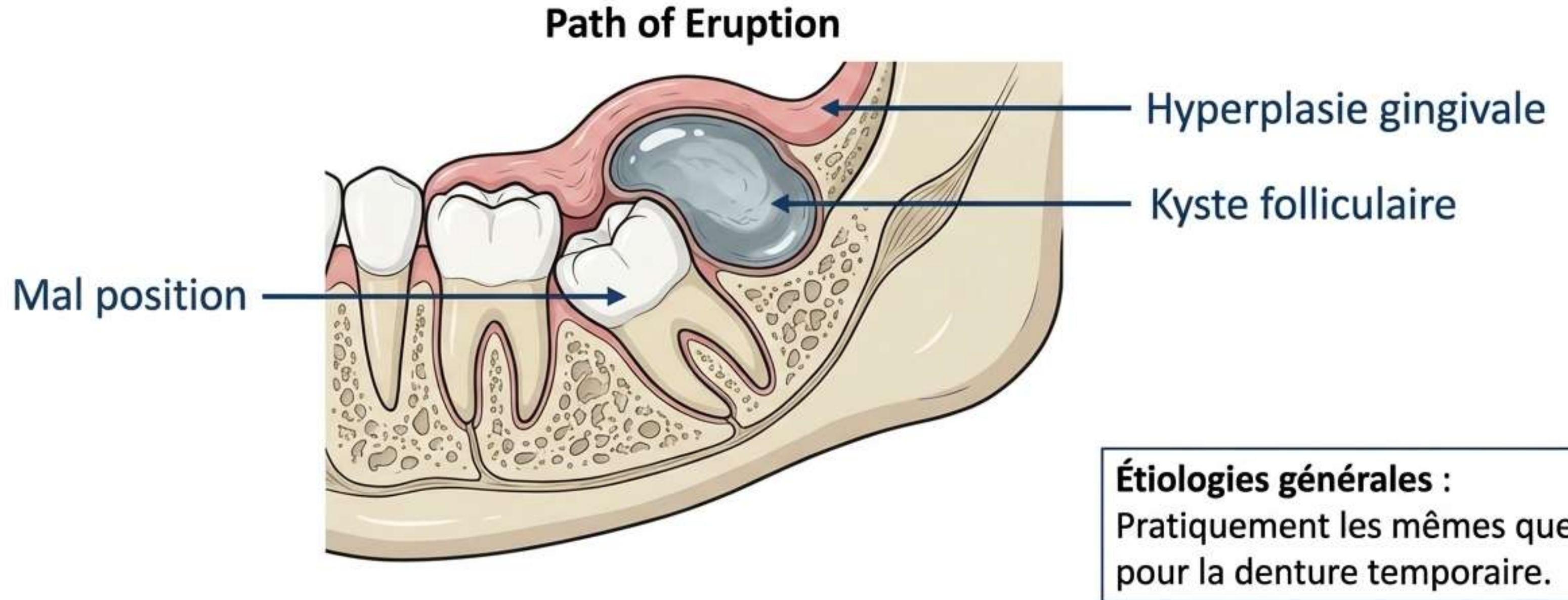
- **Carentielles** : **carence en Vit D, Vit A** [Ref: Q4(2020)].
- **Endocriniennes** : hypothyroïdie, hypoparathyroïdie.
- **Génétique** : **syndrome de Gardner, trisomie 21...** [Predicted - High-yield genetic link].





# Étiologies du Retard en Denture Permanente

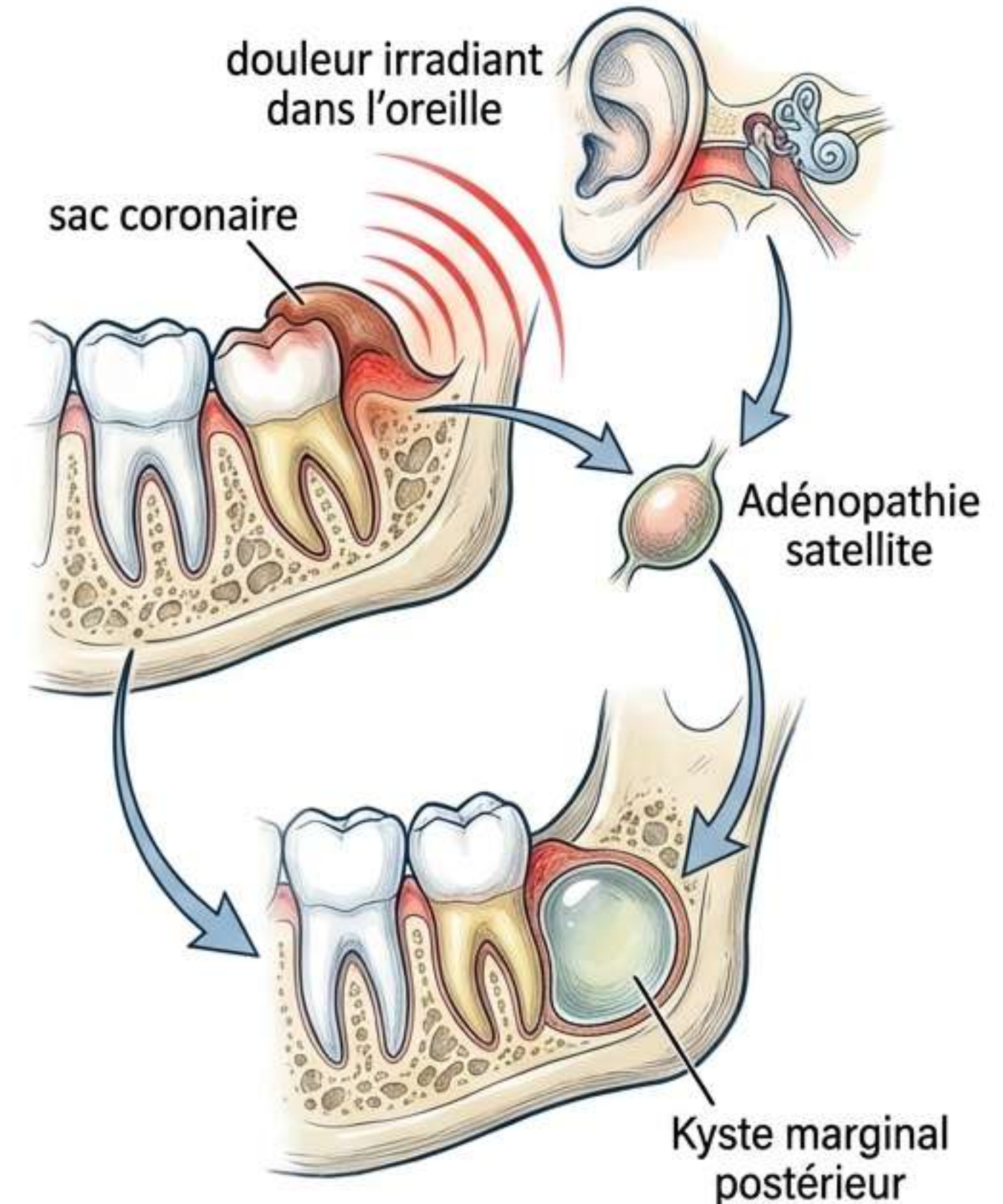
Elle est généralement liée à un facteur local comme une mal position, une hyperplasie gingivale, un trouble de l'occlusion, ou encore une anomalie de morphologie osseuse alvéolaire [Ref: Q20(2024), Q19(2023)].





# Accidents d'Éruption : La Péricoronarite (DDS +++)

- La pathologie la plus fréquente est la **péricoronarite**, correspondant à une inflammation du sac péri coronaire [Ref: Q17(2021) - Role of follicle anatomy].
- **Symptômes Cliniques** : Fièvre, douleur rétro-molaire irradiant dans l'oreille avec inflammation de la gencive en regard de la dent causale. Pression douloureuse (pus/sérosité). Adénopathie satellite fréquente.
- **Prise en Charge** : Bilan radiologique indispensable. Traitement médical ou avulsion.
- **Complication Majeure** : La répétition aboutit à un **kyste inflammatoire** : le kyste marginal postérieur [Predicted - Specific named complication].





# Diagnostic Spatial : Anomalies Topographiques

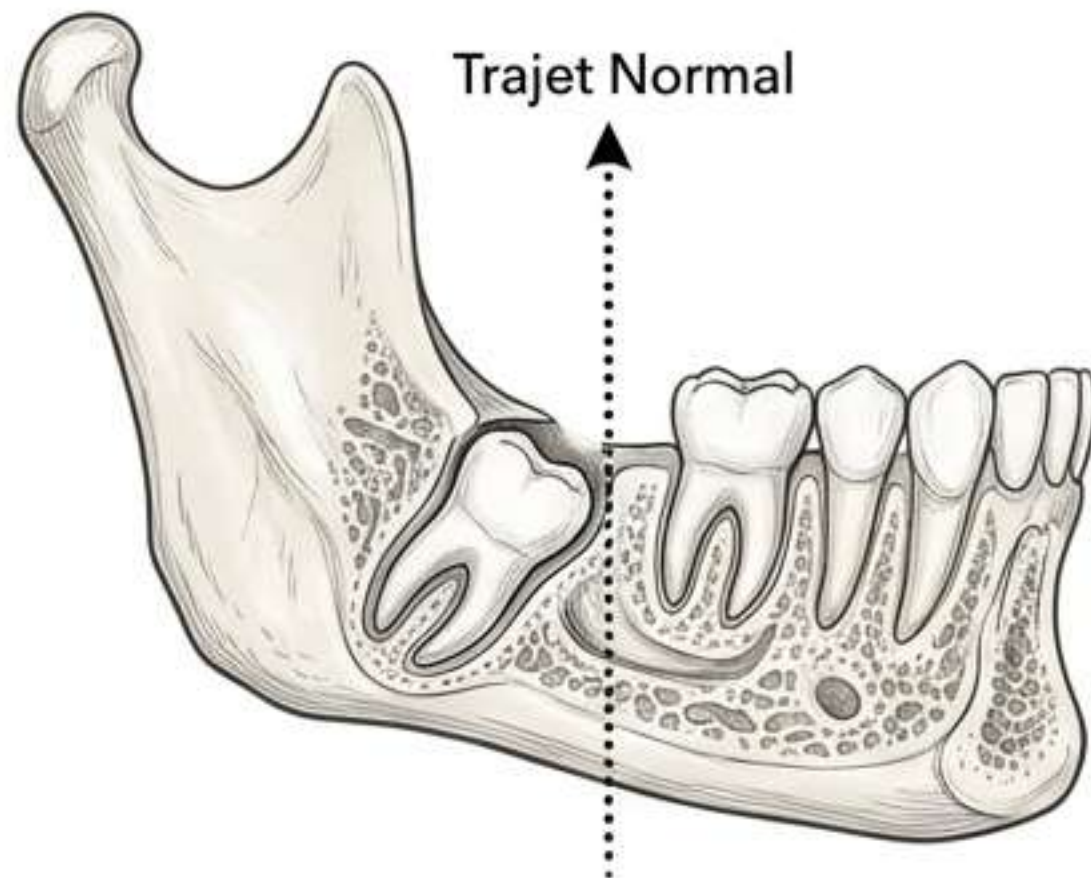
## Dent Incluse

Située à distance de l'arcade dentaire, mais sur son trajet normal de migration [Ref: Q1(2021)].

La cavité péricoronaire ne présente aucune communication avec la cavité buccale.

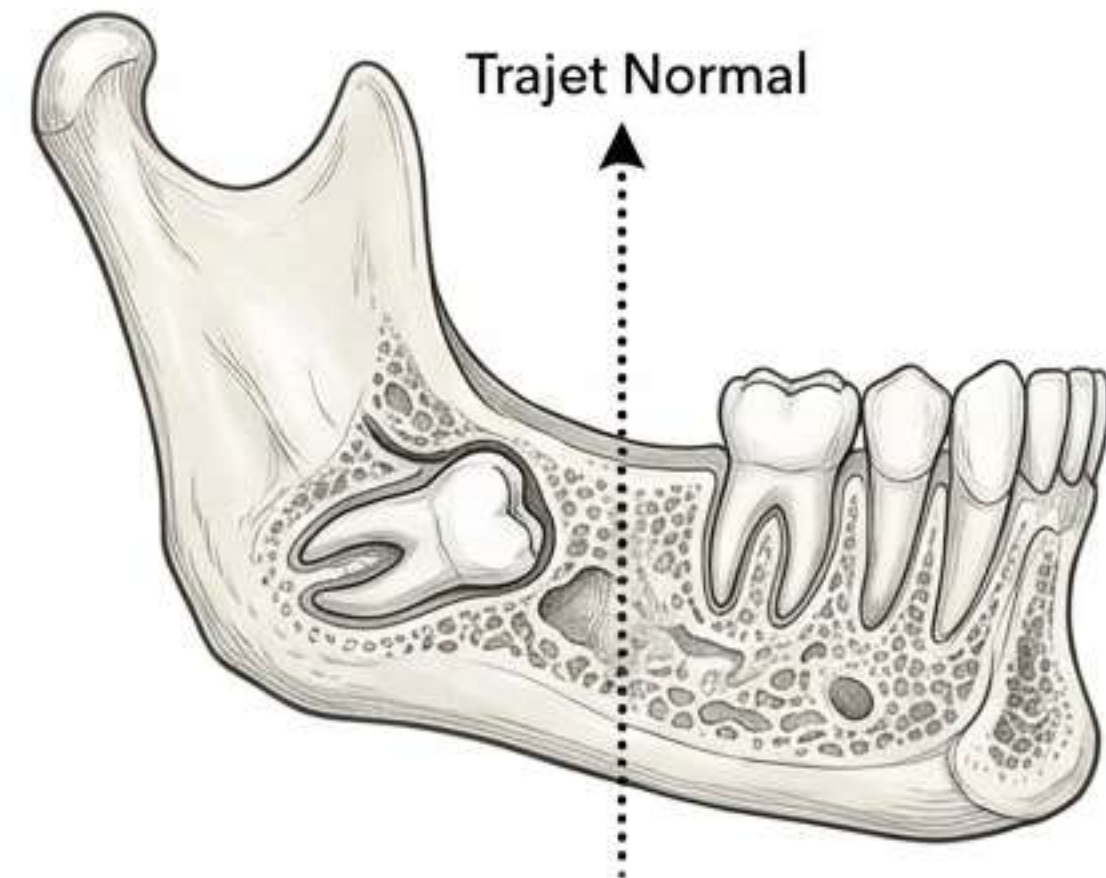
Mandibule : surtout dents de sagesse.

Maxillaire : le plus souvent la canine.



## Dent Ectopique

C'est une dent située à distance de l'arcade dentaire et en dehors du trajet normal de migration [Predicted - Strict definitional contrast].

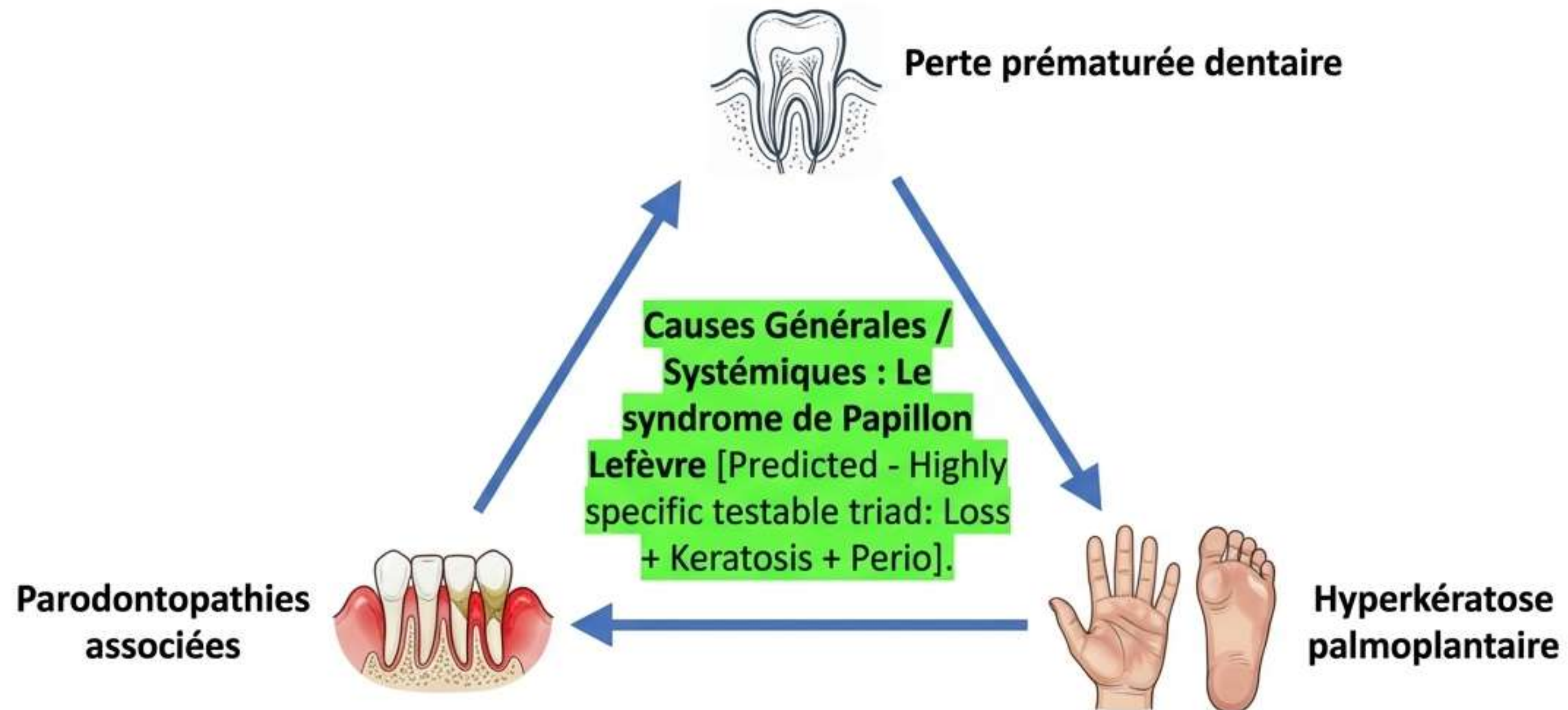




# Anomalie Terminale : Perte Prématuurée des Dents Permanentes

Phénomène consécutif à **deux catégories de causes** :

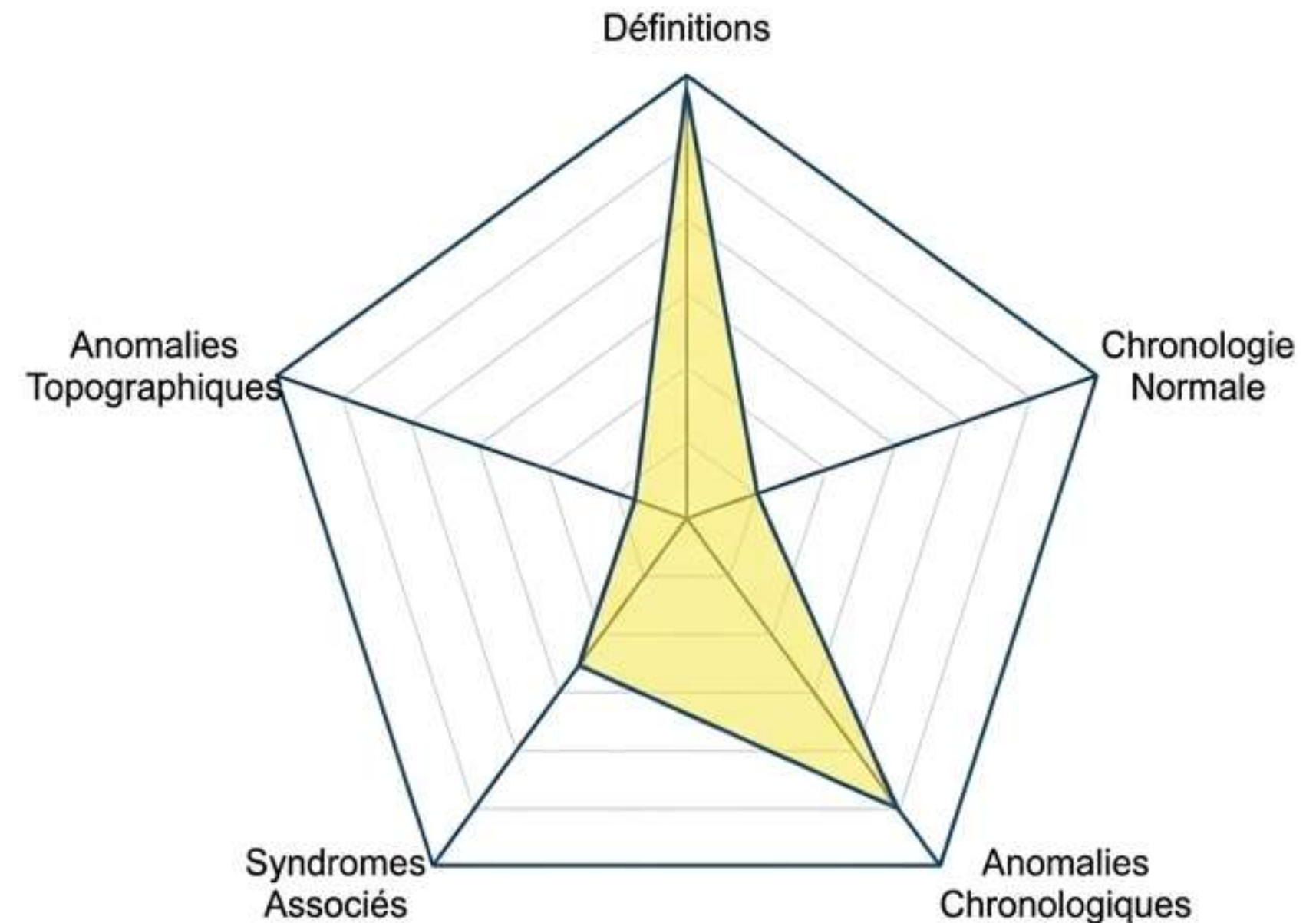
**Causes Locales / Acquises** : Pathologie infectieuse, traumatisme, ou évolution de la maladie carieuse en l'absence de traitement.





# Exam Pattern Analysis (Analyse des QCM Passés)

- **Most Repeated Topics (Yellow Zones) :**
  - Les définitions exactes du processus d'éruption (processus physiologique/émergence tissulaire).
  - Les seuils mathématiques du retard d'éruption (6 mois vs 1 an).
- **Frequently Tested Nuances :**
  - La distinction entre dent natale (à la naissance) et néonatale (1er mois).
  - Les étiologies générales (Vit A/D) vs locales (malpositions) selon le nombre de dents impactées.
- **Prediction Confidence (Green Zones) : 95%**
  - Les pièges futurs se concentreront sur les syndromes spécifiques (Papillon Lefèvre, Chérubisme, Histiocytose X, Gardner) et la distinction spatiale exacte (incluse vs ectopique).





# Architecture Synthétique : L'Éruption Dentaire

